Kotěrova Jaroslava, poj. 205

St.p. kolapsovém stavu, na CT a následně MR mozku nález objemné expanze T vpravo s šířením do inzuly, thalamu, mesencefala, pedunklu vpravo, sytící se porce je T vpravo, nesytící se oblasti pak infiltrují středočárové struktury, šíření i kontralaterálně do ncl. caudatus.

T.č. st.p. resekci tumoru 7.8.2026.

Histologie - jde o struktury high grade glialniho tumoru, aktivita měřená indexem Ki67 je velmi vysoká, místy až 70%

Pooperační MR - St.p. resekci GBM vpravo T, rozsáhlé nesytící se reziduální TU hmoty lemují mediální oddíly pravé hemisféry včetně přesahu do CC, taktéž trigonum pravé komory, kde je větší zakrvácení, kt. komoru vs. komprimuje. Postkontrastně dva okrsky sycení v rezid. TU hmotách- F bazálně a v herniovaném uncus gyri hippocampi.

Obj. levostranná hemipareza, levostranný neglect syndrom

Vzhledem k rozsahu tumoru (propagace do thalamu a mesencephala) symptomatická terapie?